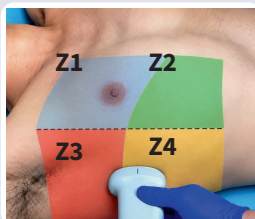


Dyspné, hypoxi, bröstsmärta eller thoraxtrauma.

Frågor: glidning? pleuralinjen? lung point? B-linjer? pleuravätska? konsolidering?

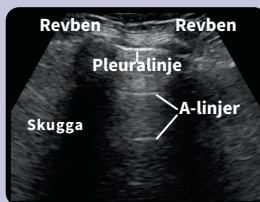
ZONER



Zoner · fyra per sida

- Z1–4 höger, Z5–8 vänster (spegelvänt).
- Övre/nedre delas vid mamillnivå, anteriort/lateralt vid främre axillarlinjen.
- **Z4/Z8:** visa även diafragma.
- Dorsala vyer vid misstänkt konsolidering.

TEKNIK



Teknik · och normalbild

- Bukprob, markör kranialt, vinkelrätt mot revbenen. Djup 8–12 cm.
- Sök två revben med skuggor och pleuralinjen emellan.
- Slep flera interkostalrum i varje zon.
- **Normalt:** tunn, glatt pleuralinje som glider, plus A-linjer.

Pneumothorax (PTX)?

Glidning, lungpuls eller B-linjer: ingen PTX på den platsen.

Utebliven glidning räcker inte ensamt.

Lung point talar starkt för PTX – ligger mer lateralt vid stor PTX och saknas vid total.

Osäkert vid KOL, fibros eller tidigare pneumothorax.

Fallgropar Djup under 8 cm: Z-linjer kan tas för B-linjer – B-linjer når bildkanten. För hög gain döljer A-linjer och överdriver B-linjer. Sned probvinkel ger falskt tjock pleuralinje. Subkutant emfysem ger E-linjer från bröstkorgsväggen.

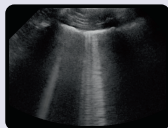
LUFT



A-linjer

Luftförande

Mer luft



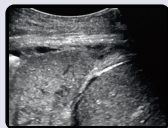
B-linjer

≥3 per revbensrum



Konfluerande

"Vit lunga"



Konsolidering

Vävnadsläk

Mindre luft

Var finns B-linjerna?

Generella bilateralt, mest deklivt: lungödem eller hjärtsvikt, ofta med pleuravätska.

Fokala i en eller få zoner: pneumoni, kontusion, infarkt, atelektas.

Generella med sparade partier, ojämn pleura och subpleurala konsolideringar: kan tala för ARDS.

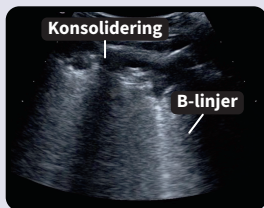
VÄTSKA



Pleuravätska

- Ses lättast i Z4/Z8 hos liggande patient.
- **Spine sign**: kotpelare ovan diafragma – vätska eller konsolidering.
- Curtain sign eller spegelartefakt talar emot vätska.
- Bedöm mängd: liten, måttlig eller stor.

KONSOL.



Konsolidering

- Vanligast basalt: leta i Z4/Z8 och strax dorsalt.
- **Dynamiskt** luftbronkogram talar för pneumoni; statiskt även vid atelektas.
- **Shred sign**: ojämn gräns mot luftförande lunga.

Konsolidering är ett fynd, inte en diagnos. Normalt lungultraljud utesluter inte pneumoni eller lungemboli.